

COGNOME LOFINO

NOME Samuele

ETÀ 30 anni

ATTIVITÀ SPORTIVA Ciclismo a livello agonistico

MOTIVO DELL'ESAME Valutazione medico-sportiva in soggetto portatore di valvola polmonare bicuspidale con steno-insufficienza e dilatazione del tronco dell'arteria polmonare

ESAME ECOCARDIOGRAFICO MONO-BI-TRIDIMENSIONALE E COLOR DOPPLER

Peso 71 Kg Statura 184 cm Sup. corporea 1.93 m² BMI 21.0 Qualità tecnica: buona

Ventricolo sinistro: Dd 48.5 mm (99.5 ml, 51.6 ml/m²) Ds 28.5 mm (33.8 ml, 17.5 ml/m²) ΔF 41% FE 65% GLS -20.1
SIV 9.5-10.5 mm PP 10 mm Cinetica: globale nella norma

Valvola mitrale: normale per morfologia Rigurgito: lieve
Onda E 0.85 m/sec Onda A 0.45 m/sec E/A 1.9

Normali il profilo Doppler del flusso venoso polmonare e le velocità di rilasciamento intramiocardiche al TDI del ventricolo sin. (E/E' 5.9)

Aorta: Bulbo 31-32.5 mm (Z-Score -0.22|0.32) Apertura valvolare 24.5 mm Aorta ascendente 28.5 mm (Z-Score 0.21)
Valvola: normale per morfologia Rigurgito: minimo
Velocità di picco sistolico transvalvolare 1.3 m/sec
Arco Aortico 25 mm Velocità di picco sistolico Ao discendente 1.4 m/sec

Coronarie: osti visibili ed in sede abituale

Atrio sinistro: 33.5 mm (38.7 ml, 20.1 ml/m²)

Ventricolo destro (M-mode): 23 mm (20.2 cm², 10.5 cm²/m²); RVD₁ 40 mm, RVD₂ 25 mm; RVOT₁ 23.5 mm, RVOT₂ 25.5 mm; spessore della parete libera 6 mm; normale funzione sistolica globale (TAPSE 21 mm, onda s' 13.4 cm/sec, FAC 47%); cinetica globale e segmentaria conservate

Valvola tricuspidale: normale per morfologia e funzione Rigurgito: assente
(velocità rigurgito di picco: 2.8-2.9 m/sec; gradiente: 31-34 mmHg; pressione stimata in atrio destro: 3 mmHg)

Valvola polmonare: cuspidi lievemente trattenute Rigurgito: lieve
(velocità di picco sist. transvalvolare: 2.05-2.25 m/sec; gradiente di picco: 16-20 mmHg; gradiente medio 7.2-8.1 mmHg)

Pericardio: piccolo spazio ecoprivo lungo la parete laterale del ventricolo sinistro e la parete basale del ventricolo destro, di significato aspecifico

Note: severa dilatazione del tronco comune polmonare (2 cm sopra la valvola, 39 mm in diastole, z score 4.1), con maggiore dilatazione dell'arteria polmonare sinistra (all'imbocco 24.5 mm) rispetto alla destra (18-20 mm).

CONCLUSIONI

Ventricolo sinistro di normali dimensioni interne e spessori parietali ai limiti superiori in relazione all'età, alla costituzione corporea ed al grado di allenamento atletico, con funzioni sistolica e diastolica conservate. Rimanenti cavità cardiache nella norma. Lieve insufficienza mitralica in valvola normoconformata. Lieve steno-insufficienza della valvola polmonare associata a severa dilatazione del tronco comune polmonare. Restanti apparati valvolari sostanzialmente normali per morfologia e funzione.
Utili controlli nel tempo.

Roma, 5 marzo 2026

Prof. Vincenzo Palmieri

Dr. Massimiliano Bianco